

# 만성 B형간염, 이렇게 관리합니다

2026 새 진료 기준 — 간수치가 아니라 '혈중 바이러스 양'으로 보고, 더 일찍 치료합니다

## 우리나라 간암의 가장 큰 원인

B형간염은 간경변·간암으로 이어지는 핵심 위험 요인입니다

**120만명**

국내 B형간염 감염자(추정)

유병률 3% 미만 · 40~60대는 3~4%

**22.2%**

치료받는 비율

환자 5명 중 1명만 치료받습니다

**18.9명**

간질환 사망(인구 10만 명당)

세계보건기구 목표(4명 이하)의 4배 넘게

### 간암 원인 1위

우리나라 간암의 가장 큰 원인이 B형간염입니다. 간경변을 거쳐, 때로는 간경변 없이도 간암이 생깁니다.

### 먹는 약이 있습니다

효과적이고 안전한 먹는 약이 있습니다. 치료가 필요한 분을 놓치지 않는 관리가 간암과 사망을 줄입니다.

Tip · 증상이 없어도 '치료가 필요한 상태'일 수 있습니다 — 정기 진료로 확인합니다.

근거 · 국내 역학 · 대한간학회 2026 만성 B형간염 진료 가이드라인

## 간에 오래 머무는 바이러스

대부분 어릴 때 감염되어, 증상 없이 수십 년 함께 지냅니다

### 👤 감염 경로 — 대부분 '엄마 → 아기'

우리나라 환자는 대부분 출생 전후에 감염됩니다. 우리나라에 흔한 유전자형(C형)은 감염 기간이 길어 간경변·간암 위험이 외국보다 높습니다.

### 🏥 증상 — 대부분 없습니다

간은 '침묵의 장기'라 피곤함 외에는 신호가 거의 없습니다.

### 🩺 확인 — 간단한 피검사

표면항원 검사로 감염 여부를, 혈중 바이러스 양·간수치·초음파로 진행 정도와 치료 필요성을 봅니다.

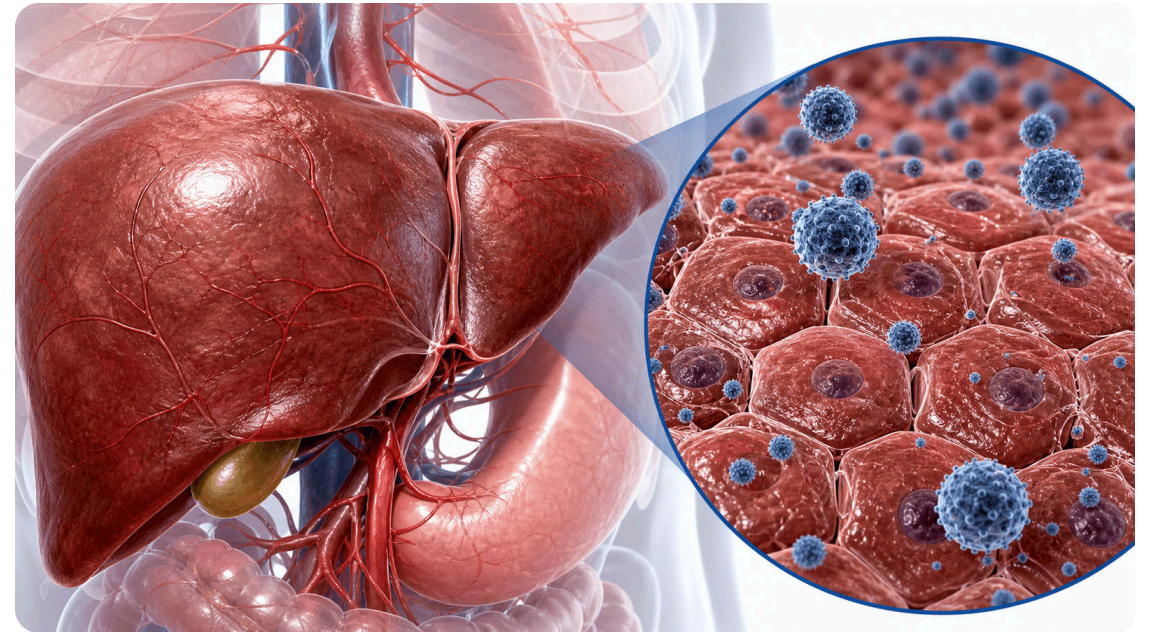


그림 · 간과, 간세포 사이의 B형간염 바이러스(파란 알갱이)를 확대한 설명용 그림입니다.

Tip · 가족 중 B형간염이 있으면 증상이 없어도 피검사로 확인해 보세요.

근거 · 대한간학회 2026 만성 B형간염 진료 가이드라인

## 증상 없이 조용히 진행합니다

치료하지 않으면 간이 서서히 굳고, 일부는 간암으로 진행합니다

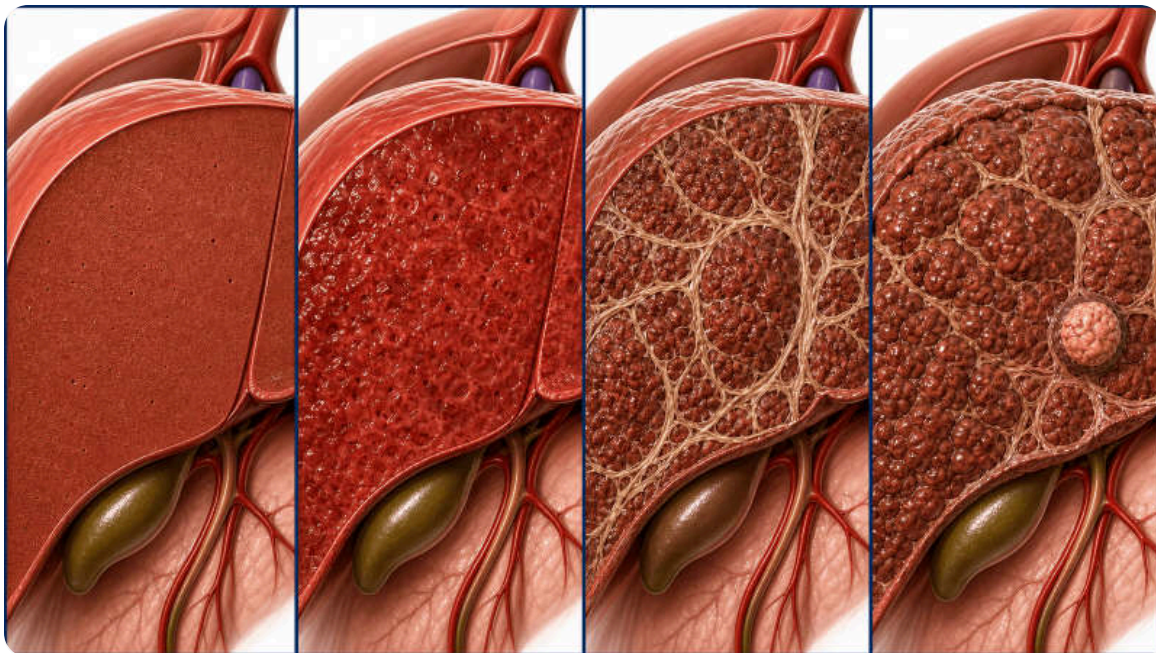


그림 · 왼쪽부터 염증 → 섬유화 → 간경변 → 간암(혹)입니다(설명용 그림).

Tip · '아무 증상이 없다'는 말이 '진행하지 않는다'는 뜻은 아닙니다.

### 1 만성 염증 시작

바이러스가 간세포에 계속 머물며 염증이 반복됩니다.

### 2 간섬유화 흉터

염증이 쌓이며 간이 점점 딱딱해집니다.

### 3 간경변 굳음

간이 크게 굳어 기능이 떨어지고 합병증이 생깁니다.

### 4 간암 감시 필수

간경변이 없어도 생길 수 있어 정기 감시가 필요합니다.

근거 · 만성 B형간염 자연경과 · 대한간학회 2026 만성 B형간염 진료 가이드라인

## 이제 '혈중 바이러스 양'으로 봅니다

2026년부터 간수치 중심에서 혈중 바이러스 양 중심으로 분류가 바뀌었습니다

| 구간 | 바이러스 양 (IU/mL) | 의미                               |
|----|----------------|----------------------------------|
| 적음 | 2천 미만          | 간경변이 없으면 대체로 경과가 좋습니다            |
| 중간 | 2천~1억          | <b>간암 위험이 가장 높은 구간</b> 으로 확인됐습니다 |
| 많음 | 1억 초과          | 바이러스 양이 매우 높은 단계입니다              |

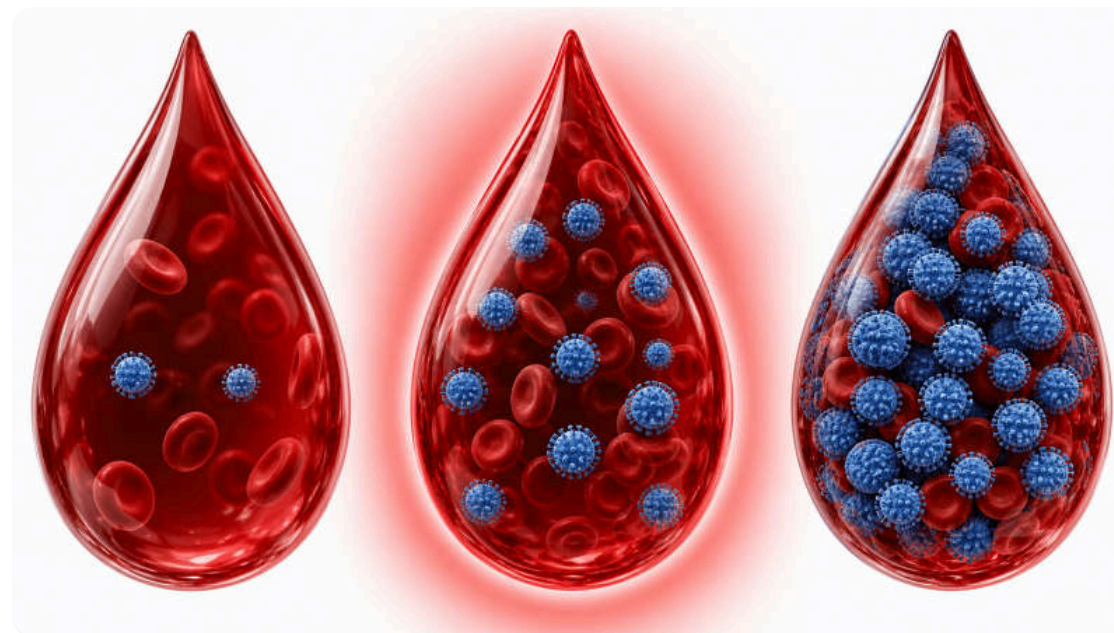


그림 · 왼쪽부터 바이러스 양 적음 · 중간(붉게 강조) · 많음을 나타낸 설명용 그림입니다.

Tip · 'IU/mL'은 피 1mL에 든 바이러스 양을 나타내는 단위입니다.

근거 · 바이러스 양 기반 자연경과 분류 · 대한간학회 2026 만성 B형간염 진료 가이드라인

## 간수치가 정상이어도 치료할 수 있습니다

예전엔 '간수치가 올라야' 치료했지만, 이제는 다릅니다

### 예전 기준 (~2022)

간수치가 정상 상한의 2배 이상 올라야 치료

- 바이러스가 많아도 간수치가 정상이면 '경과관찰'
- 중간 바이러스 양 구간이 치료의 사각지대

VS

### 새 기준 (2026)

바이러스 양을 기준으로 치료 여부 결정

- 간수치가 정상이어도 위험 구간이면 치료 시작
- 치료 대상이 넓어지고 판단이 단순해짐

**왜 바뀌었나** 간수치가 정상이어도 바이러스에 의한 발암 과정은 진행될 수 있어, 간수치만으로는 간암을 충분히 막기 어렵습니다.

Tip · 예전에 '아직 치료 안 해도 된다'는 말을 들었다면 새 기준으로 다시 확인해 보세요.

근거 · 치료 대상 확대 · 대한간학회 2026 만성 B형간염 진료 가이드라인

# 누가 치료를 시작하나요?

혈중 바이러스 양과 간 상태로 판단합니다 — 실제 치료는 진료의가 종합해 정합니다

| 상태(바이러스 양 IU/mL) | 어떻게 하나                                | 치료  |
|------------------|---------------------------------------|-----|
| 중간 · 2천~1억       | 간암 위험이 가장 높은 구간 — 간수치와 관계없이 치료 시작     | 시작  |
| 많음 · 1억 초과       | 30세 초과·간수치 상승·간섬유화 중 하나면 치료, 없으면 경과관찰 | 조건부 |
| 적음 · 2천 미만       | 간경변이 없으면 경과관찰 — 간수치가 오르면 다른 원인도 확인    | 관찰  |
| 간경변이 있음          | 바이러스가 검출되기만 하면 양과 관계없이 치료 시작          | 시작  |

**건강보험 안내** 위는 학회 권고입니다. 현재 급여는 기존 기준(간수치 상승 등)을 적용해, 간수치가 정상이고 간경변이 없으면 중간 구간이라도 아직 급여가 안 될 수 있습니다.

Tip · 치료를 시작하지 않아도 3~6개월마다 혈액검사(간수치·바이러스 양)로 치료 시점을 놓치지 않게 추적합니다.

근거 · 치료 대상 및 전략 · 대한간학회 2026 만성 B형간염 진료 가이드라인

# 하루 한 알로 바이러스를 누릅니다

효과 좋고 안전하며 내성이 거의 없는 먹는 항바이러스제

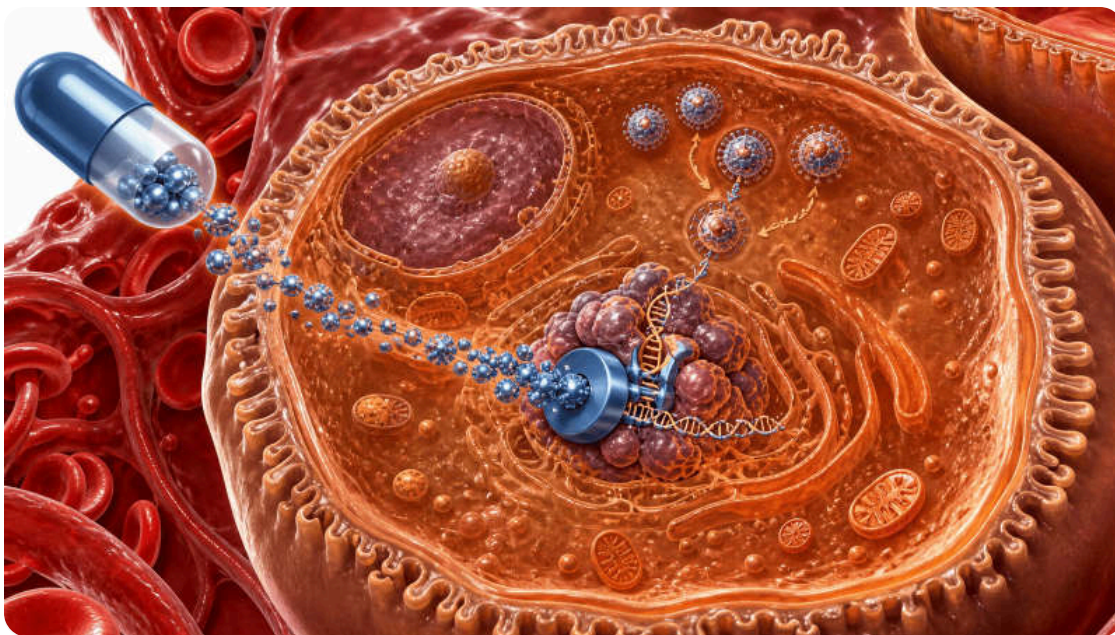


그림 · 먹는 약이 간세포 안에서 바이러스가 불어나는 과정을 막는 모습을 그린 설명용 그림입니다.

Tip · 다른 병으로 약을 먹고 있다면 처방 전에 모두 알려 주세요.

## 1차 치료제

테노포비어 · 엔테카비어 · 베시포비어 — 하루 한 알로 바이러스 증식을 강하게 누르고, 약이 안 듣게 되는 경우(내성)가 매우 드뭅니다.

## 효과 — 간암·사망 위험을 낮춤

오래 복용하면 간경변 진행을 막고 간암 발생과 사망을 줄이는 효과가 확인됐습니다.

## 상태에 맞춰 약을 고릅니다

콩팥·뼈가 약하면 그에 맞는 약으로, 임신 중에는 테노포비어로 선택합니다.

근거 · 항바이러스제 · 대한간학회 2026 만성 B형간염 진료 가이드라인

# 오래 먹지만, 스스로 끊으면 위험합니다

목표는 바이러스를 눌러 간암을 막고, 더 나아가 '기능적 완치'에 이르는 것



01

## 대부분 오래 복용합니다

대부분 오랜 기간 꾸준히 먹습니다. 중단 여부는 반드시 진료의와 상의해 정합니다.

꾸준히 복용



02

## 스스로 끊으면 안 됩니다

간염이 갑자기 악화되거나 간 기능이 나빠질 수 있습니다. 우리나라에 흔한 C형은 중단 뒤 재발·악화 위험이 큼니다.

임의 중단 금지



03

## 치료 목표

단기 — 혈중 바이러스를 검출되지 않게  
 장기 — 표면항원까지 사라지는 '기능적 완치'  
 궁극 — 간경변·간암 예방

완치 뒤 종료 고려

Tip · '기능적 완치'에 이르면 그때 치료 종료를 함께 검토할 수 있습니다.

근거 · 치료 목표·치료 종료 · 대한간학회 2026 만성 B형간염 진료 가이드라인

## 치료 여부와 관계없이 정기검사

간암은 일찍 발견할수록 잘 치료됩니다 — 6개월마다 챙기세요

### 1 간암 감시검사 6개월마다

40세 이상이거나 간경변이 있으면 복부 초음파 + 간암 표지자 혈액검사 (AFP)를 받습니다.

### 2 혈액검사로 추적 정기적으로

간수치·바이러스 양을 확인하고, 치료 중에는 콩팥 기능도 함께 봅니다.

### 3 치료 전이어도 추적 3~6개월마다

지금 치료하지 않는 분도 간수치·바이러스 양 혈액검사로 치료가 필요해지는 때를 놓치지 않습니다.



그림 · 복부 초음파로 간을 살펴보는 모습입니다. 혈액검사와 함께 받습니다(설명용 그림).

Tip · 검사 날짜를 달력이나 휴대폰에 미리 적어 두면 놓치지 않습니다.

근거 · 간암 감시·치료 중 모니터링 · 대한간학회 2026 만성 B형간염 진료 가이드라인

## 임신·다른 치료 때 꼭 챙길 것

상황에 따라 미리 준비하면 위험을 크게 줄일 수 있습니다

### 임신 — 아기 감염 예방

바이러스가 많으면(20만 IU/mL 이상) 임신 중 항바이러스제(테노포비어)로 아기 감염을 예방합니다.

### 출산·수유

아기는 출생 직후 백신 + 면역글로불린으로 보호합니다. 치료 중이 아니면 모유수유가 가능합니다.

### 항암·면역억제 치료 전

항암치료·면역억제제·스테로이드 전에는 B형간염 검사가 꼭 필요합니다 — 바이러스가 다시 활동해 악화되는 것을 막습니다.

### 가족도 검사·예방접종

함께 사는 가족은 검사를 받고, 항체가 없으면 예방접종으로 미리 보호합니다.

Tip · 임신 계획이 있거나 새로운 치료를 시작하면 먼저 알려 주세요.

근거 · 특정 상황에서의 치료 · 대한간학회 2026 만성 B형간염 진료 가이드라인

## 오늘부터 실천하기

꾸준함이 간을 지킵니다

**01** 처방받은 약은 매일 같은 시간에 거르지 않고 복용

**02** 약을 스스로 끊거나 거르지 않기 — 중단은 진료의와 상의

**03** 6개월마다 간암 감시검사(초음파+혈액)와 정기 진료

**04** 금주 — 술은 간 손상과 간암 위험을 높입니다

**05** 항체가 없으면 A형간염 예방접종 받기

**06** 가족 검사·예방접종 챙기기

**07** 다른 약·한약·건강기능식품은 먹기 전에 상담

Tip · 예방접종 일정과 바로 병원에 와야 할 신호는 따로 드리는 안내문에 정리돼 있습니다.

근거 · 환자 실천 핵심 · 대한간학회 2026 만성 B형간염 진료 가이드라인

## 다시 보기 · 문의

QR로 다시 보기 · 정기검사·예방접종·응급 신호는 [B형간염 안내문](#)을 드립니다

### 광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

### 이 자료의 성격

만성 B형간염으로 진료받는 분과 가족을 위한 설명자료입니다. 치료 시작·중단은 담당 의사와 상의해 정합니다.

### 참고한 자료

대한간학회 2026 만성 B형간염 진료 가이드라인 · 국내 역학 자료



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서  
같은 자료를 다시 볼 수 있어요